

ICU 栄養指標データ 2025年度

対象 2025年4月1日～2026年3月31日にICU入室した **591例** | 管理栄養士との共有用

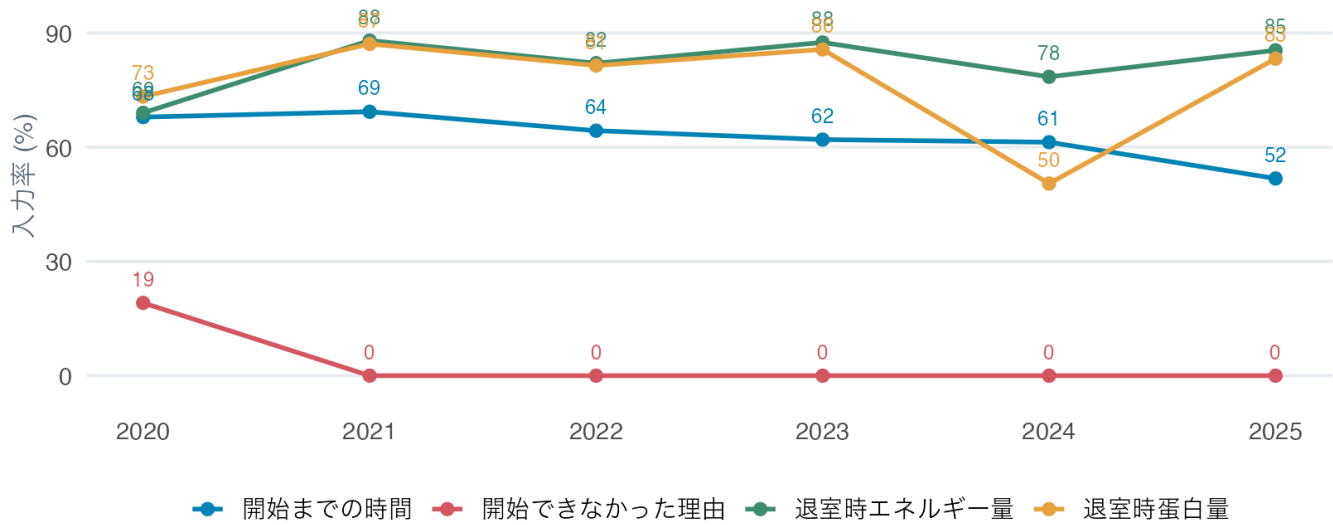
まず結論

- 退室時の栄養量（エネルギー85.4%・蛋白83.2%）はよく記録されている。不足しているのは開始時刻だけ。
- 「栄養開始までの時間」の入力は51.8%（306/591例）。毎月ほぼ一定で、途中で止まったわけではない。
- 「開始できなかった理由」欄は0%。2021年度以降まったく使われていない。これが最大の課題。
- 48時間以上ICUにいた患者に限れば、48時間以内の開始は65.1%。これが実態に最も近い数字。
- 退室時に目標量へ到達しているのは蛋白12.4%・エネルギー19.2%。開始よりも増量が課題。

1. 入力状況

入力欄	2025年度	2024年度	状態
退室時エネルギー量	85.4%	—	良好
退室時蛋白量	83.2%	—	良好
栄養開始までの時間	51.8%	61.3%	半分が空欄
開始できなかった理由	0.0%	0%	欄はあるが未使用

「開始できなかった理由」は2021年度以降ずっと0%

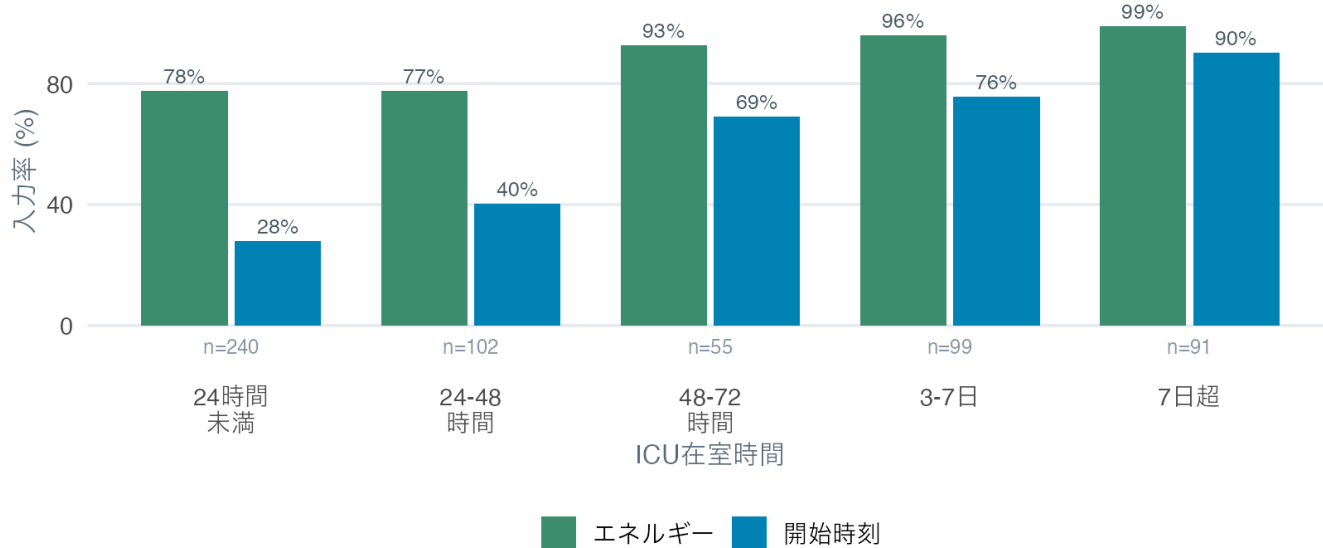


入力率の6年推移。退室時の栄養量は安定して8割前後。開始時刻は68%→51.8%と緩やかに低下している。「開始できなかった理由」は2020年度には19%使われていたが、以降は0%。

月別に見ても一定です。入力が途中で止まったのではなく、毎月おおむね半分ずつ入っています。

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
開始時刻の入力率	50%	52%	50%	55%	41%	55%	60%	47%	56%	51%	49%	54%

短期滞在ほど開始時刻が入っていない。退室時エネルギー量はどの層でも入っている

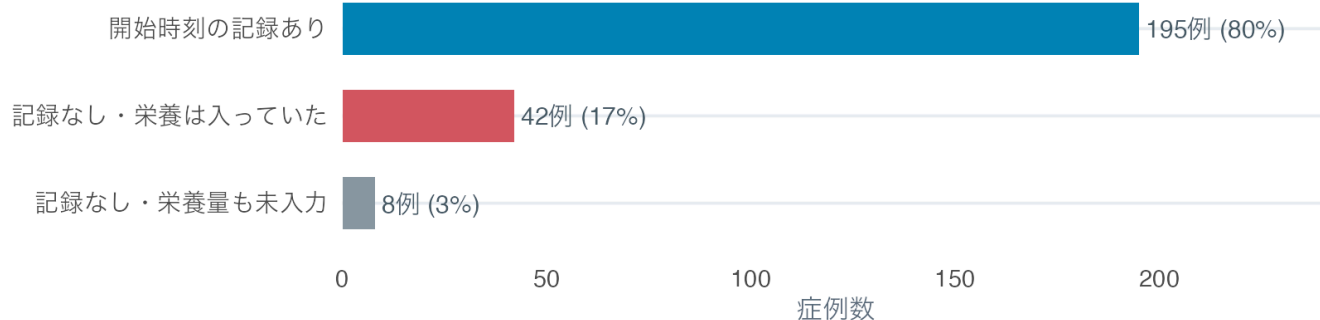


入力されていないのは、主に短期滞在の患者です。24時間未満で退室した患者は239例（全体の40.4%）あり、開始時刻の入力は27.6%。一方で退室時のエネルギー量はどの層でも記録されています。

ここから言えること：短期滞在の患者に開始時刻を記録しない運用が、事実上できあがっていると考えられます。これ自体は不合理ではありません。問題は、その「対象外」と、記録し忘れた「記録漏れ」が、どちらも空欄で区別できないことです。

2. 空欄の中身を調べました

ICUに48時間以上いた 245例の内訳



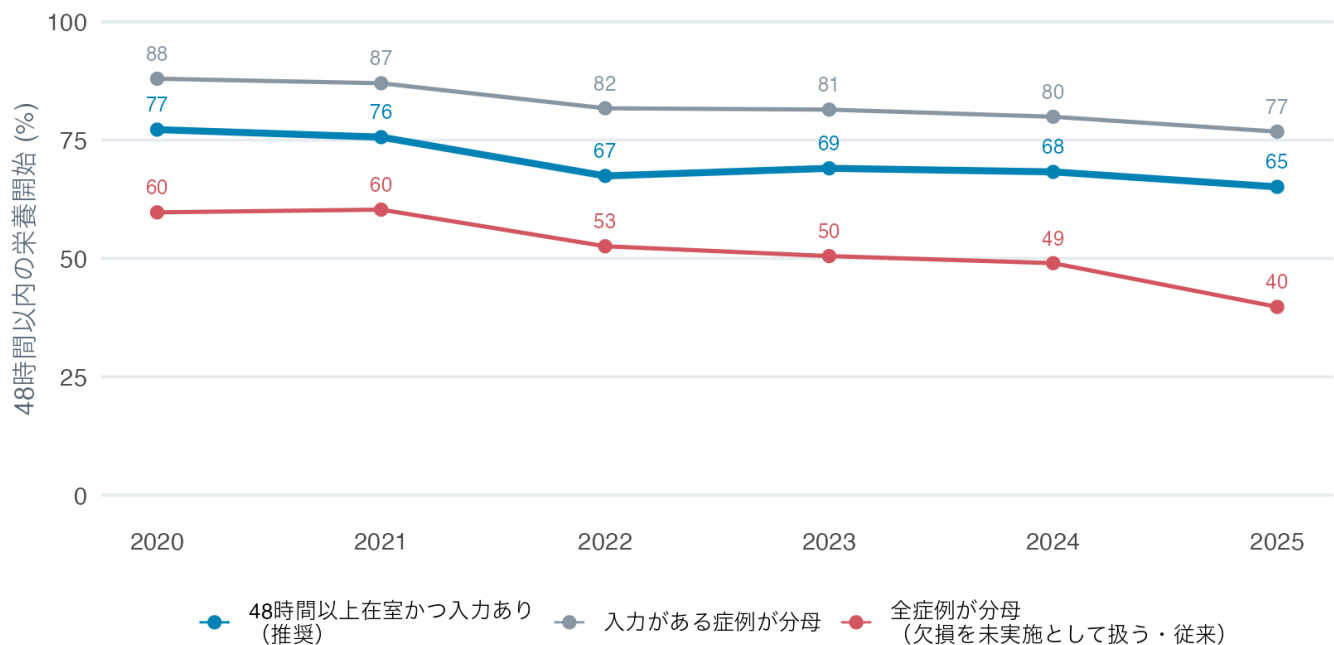
ICUに48時間以上いた245例の内訳。

状態	例数	解釈
開始時刻の記録あり	195 例	問題なし
記録なし・退室時に栄養は入っていた	42 例	記録漏れ
記録なし・栄養量も未入力	8 例	判定不能
記録なし・退室時0 kcal（本当に開始せず）	0 例	該当なし

重要：48時間以上ICUにいた患者で「栄養を開始しなかったから空欄」だった症例は**1件もありませんでした**。空欄はすべて記録が残っていないだけです。にもかかわらず昨年度版までのレポートは、空欄を「48時間以内に開始しなかった」として数えていました。

3. 数え方で結果が大きく変わります

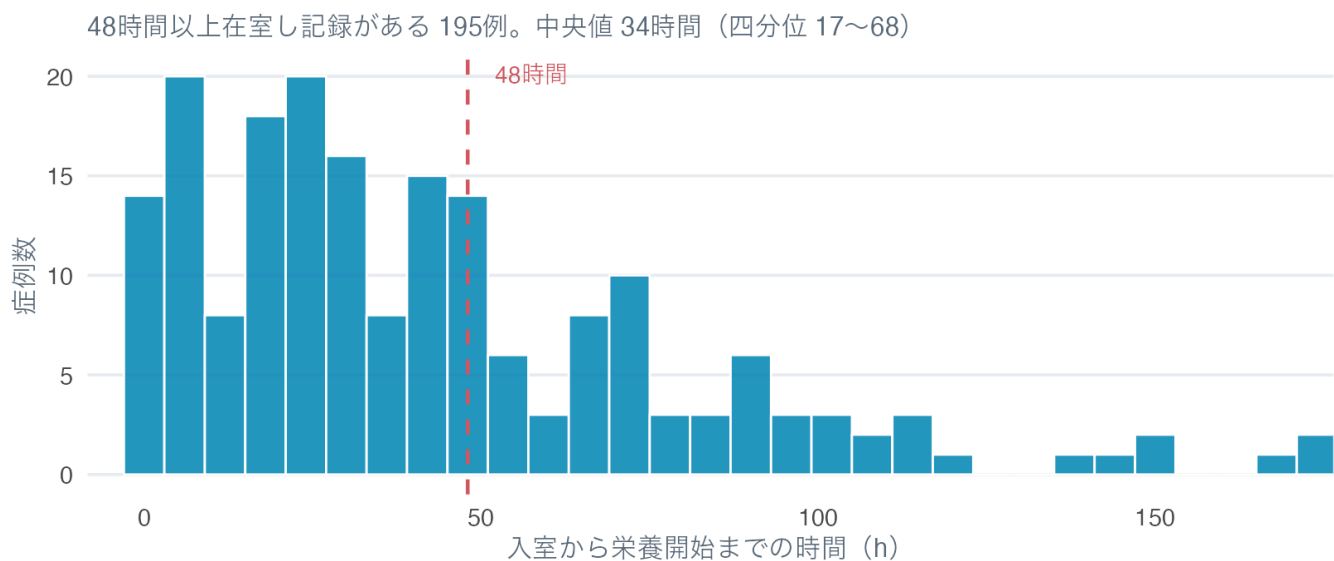
同じデータでも数え方で30ポイント以上変わる



同じデータを3通りの数え方で集計したもの。

数え方	2025年度の値	評価
全症例が分母（空欄を未実施として数える・従来）	39.8%	実施率ではなく入力率を映した数字
入力がある症例が分母	76.8%	短期滞在の術後患者を含むため高めに出る
48時間以上在室かつ入力あり	65.1%	推奨。QIとして意味を持つ範囲

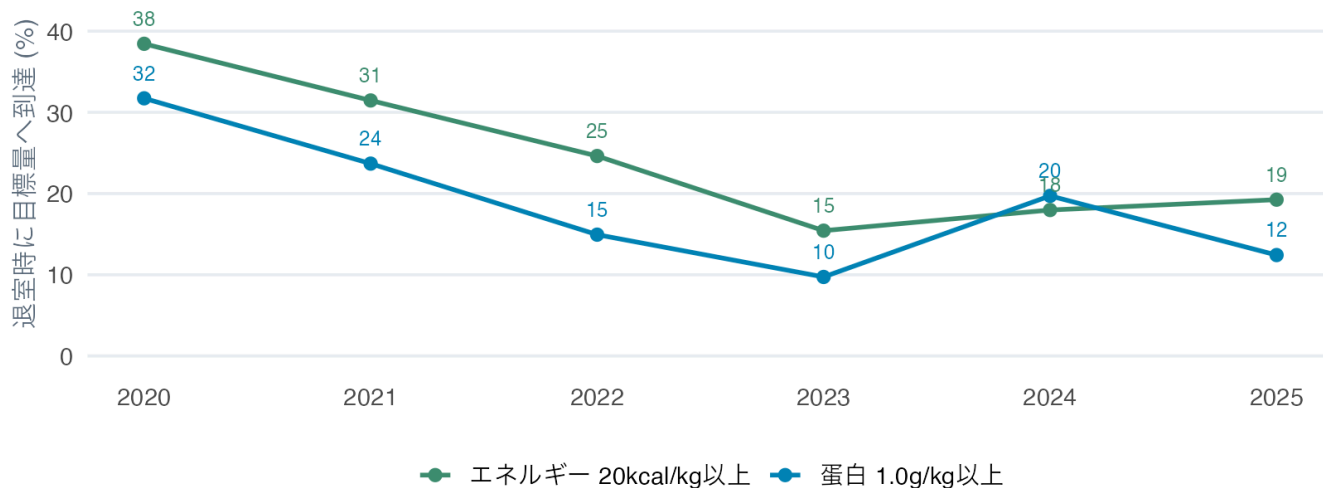
注目すべき点：推奨の数え方でも、6年間で77%→65.1%と**低下傾向にあります**。これは記録の問題ではなく、実際に早期栄養の実施が落ちている可能性を示しています。



48時間以上在室し記録がある195例。中央値34時間（四分位 17～68時間）。**48時間を超えたのは68例**。大きく遅れた症例が一定数あります。

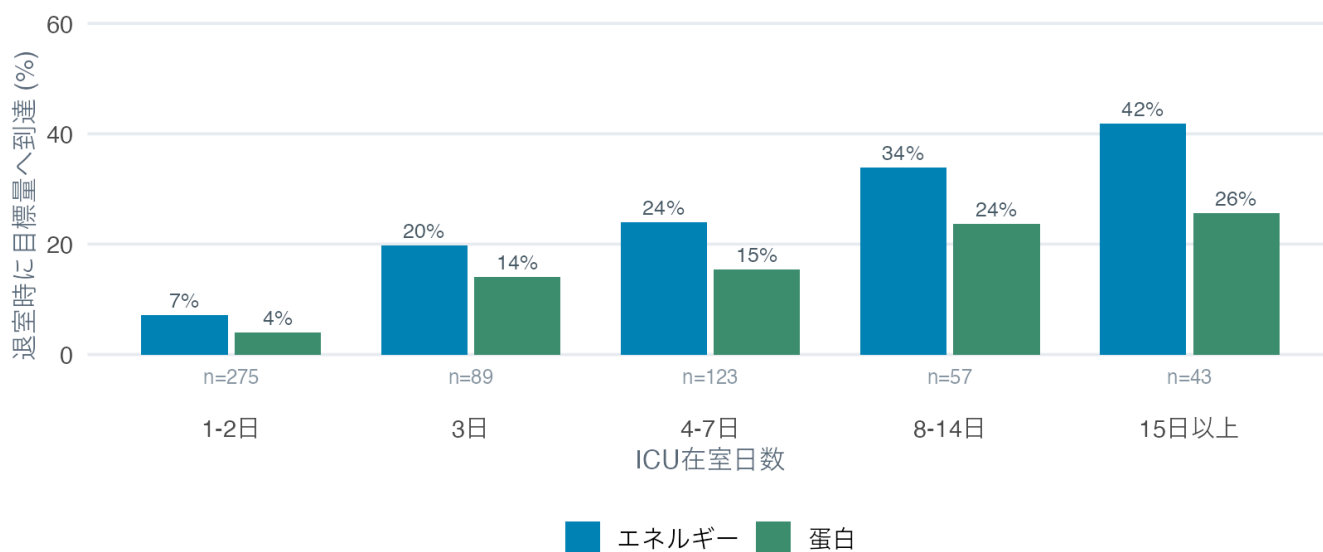
4. 量の充足（退室時）

開始は早くても、退室時までには量が積み上がっていない



退室時に目標量へ到達していた患者の割合。蛋白1.0g/kg以上、エネルギー20kcal/kg以上を目標とした場合。

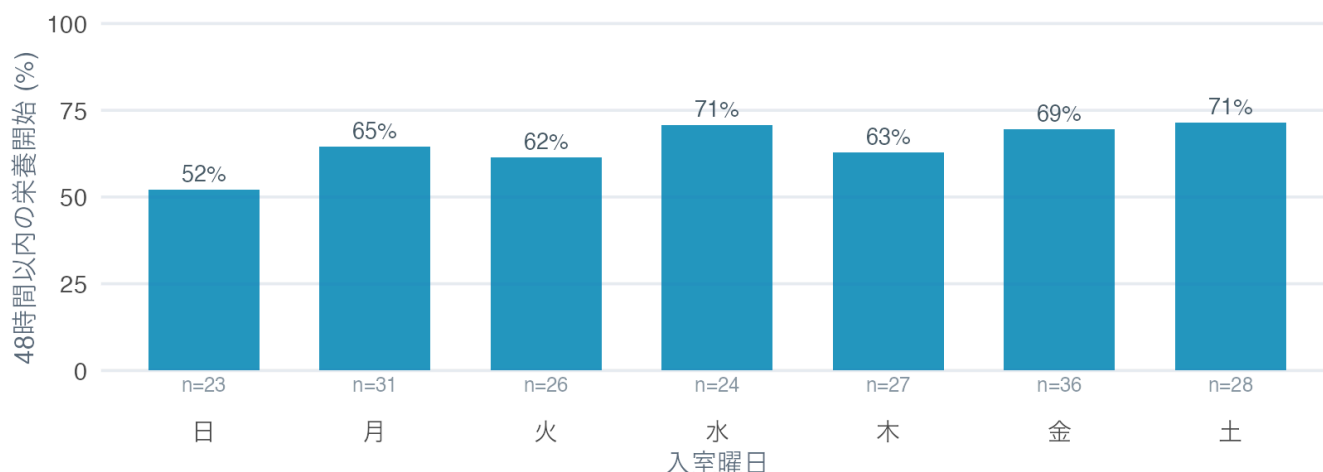
長く在室した患者ほど到達しているが、それでも半数に届かない



在室日数別の到達率。

ここが本丸かもしれません： 退室時に目標量へ到達しているのは蛋白12.4%・エネルギー19.2%にとどまります（判定できたのは蛋白491例・エネルギー504例）。長期滞在の患者ほど到達率は上がりますが、それでも半数に届きません。**開始は比較的早いのに量が積み上がっていないため、改善の余地は「開始時期」より「増量のペース」にあると考えられます。**

症例数が少ない曜日は数値が振れやすい



入室曜日別の48時間以内開始率。曜日ごとの症例数が少ないため、数値は振れやすい点に注意。

5. お願いしたいこと

- 1 「開始できなかった理由」欄を使ってください。現在0%です。空欄の意味が「対象外」なのか「未実施」なのか「記録漏れ」なのか、これがないと永久に区別できません。選択式（主科方針でNPO／消化管が使用できない／BSC・DNAR／TPNのみ／循環動態が不安定／早期退室のため未評価／その他）にすれば負担は小さくなります。
- 2 空欄を残さないでください。開始したら時刻、開始しなければ理由。どちらかは必ず埋まる状態にする。
- 3 入力対象を「ICU在室48時間以上」と決めませんか。24時間未満で退室する患者239例に毎回入力を求めるのは負担が大きく、QIとしても評価できません。対象を絞れば現在の入力率は79.6%で、残り2割を埋めれば完了します。
- 4 開始した当日に記録してください。退室時に確定する項目（栄養量）は8割入力されているのに、開始日に確定する項目（開始時刻）は半分です。退室時にまとめて入力すると開始時刻を思い出せないことが原因と考えられます。

5

「0時間」の意味を決めてください。現在4例あります。「入室時点ですでに経腸栄養中」なら0、開始しなかったなら空欄＋理由、と決めておくで集計時に迷いません。

これが実現すると：いまは「48時間以内の栄養開始=?%」という1つの数字しか出せませんが、
①48時間以内に開始できた割合（診療の質） ②開始できなかった割合と理由の内訳（改善余地の所在） ③記録漏れの割合（データ品質）の3つを分けて示せるようになります。そうなれば、退室時の目標量到達率が低い原因が開始時期にあるのか増量ペースにあるのかも切り分けられます。

聖路加国際病院 集中治療科 ICU栄養指標データ 2025年度

院内資料。患者個人を特定する情報は含まれていません。データ出典：ICU台帳／Ex-JIPAD